

Bieg z ciężarem

Wychowywanie wymaga dokładnie tych umiejętności, w których ADHD jest deficytem: rutyny, cierpliwości, regulacji. To trudniej — i to nie wina.

CZAS: 12 min czytania Po diagnozie + przy trudnościach rodzicielskich

ŹRÓDŁO: Johnston i Mash (2001); Chronis-Tuscano i wsp. (2008); Faraone i wsp. (2005, heritabilność 74%)

JAK UŻYWAĆ

Trzy filary rodzicielstwa z ADHD: **samoopieka rodzica** (sen, lek, terapia — bez tego nie ma czego dać dziecku); **struktura widoczna** w domu (rutyny, wizualne plany, alarmy dla wszystkich); **partnerstwo i wspólny system** z drugim rodzicem lub bliskim wsparciem. Pamiętaj: *nie jesteś złym rodzicem — jesteś rodzicem w trudniejszych warunkach.*

DLACZEGO TO DZIAŁA

Johnston i Mash (2001): rodzice z ADHD stosują **mniej spójne** strategie wychowawcze, reagują bardziej impulsywnie i mają trudność z utrzymaniem rutyn. Chronis-Tuscano i wsp. (2008): ADHD rodzica jest *niezależnym* czynnikiem ryzyka trudności u dziecka — niezależnie od tego, czy dziecko ma ADHD. **Dziedziczność ADHD wynosi 74%** (Faraone i wsp., 2005) — rodzic z ADHD często wychowuje dziecko z ADHD. Paradoks: rodzic z ADHD **rozumie** dziecko z ADHD lepiej niż neurotypowy — empatia z własnego doświadczenia to ogromny atut. Klucz: *samoopieka jest priorytetem*, nie luksusem. Wyczerpany/-a rodzic nie wychowuje — przetrwa dzień.

01 ? Cztery specyficzne wyzwania

1 • KONSEKWENCJA

Dziecko potrzebuje **jednakowych reakcji** dziś, jutro, w piątek. Mózg ADHD = zmienne reakcje. To trudniejsze niż dla rodzica neurotypowego — wymaga *zewnętrznych systemów*.

2 • REAKCJA NA TRUDNE ZACHOWANIE

Krzyk dziecka → szybka reakcja emocjonalna w mózgu z DESR. **Impulsywne słowa**, których później żałujesz. RSD nasila wstyd.

3 • LOGISTYKA CODZIENNA

Plecak, śniadanie, ubranie, lekcje, zajęcia, lekarz. **20 mikro-decyzji dziennie**. Funkcje wykonawcze, których brakuje, są dokładnie tymi, których potrzeba.

4 • BRAK SAMOOPIEKI

Macierzyństwo/ojcostwo „*żyje się dla dziecka*”. Samoopieka schodzi na ostatnie miejsce. Rodzic z ADHD **wypala się szybciej** niż neurotypowy. Cykl pogłębia trudności.

02 ? Sześć zasad rodzicielstwa z ADHD

1 • SAMOOPIEKA PIERWSZA

Sen 7+ godzin, lek systematycznie, terapia, ruch, posiłki. **Bez tego dziecko dostaje wyczerpaną wersję Ciebie.**

2 • RUTYNY WIDOCZNE

Plan dnia na ścianie. Plan zadań dla dziecka. Alarmy. Mózg dziecka i Twój — oba wymagają wzrokowych sygnałów.

3 • PAUZA PRZED REAKCJĄ

Trudne zachowanie dziecka → **3 oddechy zanim odpowiesz**. „Wracam za chwilę” — możesz odejść na 60 sek do innego pokoju.

4 • PARTNER JAKO SYSTEM

Jeśli partner/-ka jest neurotypowy/-a, **nie czyn go/jej proteżą**. Wspólny kalendarz, podział obowiązków, wzajemne wsparcie — nie rola opiekuna.

5 • TRENING RODZIELSKI

Trening umiejętności rodzicielskich dostosowany do ADHD. W Polsce: psychoterapia indywidualna lub coaching rodzicielski znający neuroróżnorodność.

6 • NAPRAWA PO WYBUCHU

Po impulsywnej reakcji: **napraw związek**. „Przepraszam, że krzyknąłem/-am. To moja sprawa, nie Twoja”. Modelowanie odpowiedzialności emocjonalnej.

03 🎯 Atut: rozumiesz dziecko z ADHD od środka

Jeśli Twoje dziecko ma ADHD (a statystycznie często ma), Twoje **doświadczenie z własnym mózgiem** to ogromny atut. Trzy rzeczy, których neurotypowy rodzic nie zrozumie:

„NIE UMIEM ZACZAĆ”

Nie „lenistwo” — **realna trudność aktywacji**. Pomagasz w mikro-krokach, nie krytykujesz.

„ZAPOMNIAŁEM”

Nie „nie obchodzi mnie” — **deficyt pamięci roboczej**. Tworzysz system, nie wymagasz „zapamiętania”.

„NIE CHCĘ PRZESTAĆ”

Hiperfokus, nie upór. **Uprzedzasz zmianę aktywności** 10 min wcześniej, nie zaskakujesz.

04 ✎ Twój audyt — co działa, co nie

MOJA SAMOOPIEKA

— sen, lek, ruch, terapia — co zaniedbuję

NAJTRUDNIEJSZA GODZINA DNIA

— np. poranne wyjście, wieczór, lekcje

WZORZEC WYBUCHU EMOCJONALNEGO

— co go uruchamia, kiedy

MOCNE STRONY, KTÓRE JUŻ DAJĘ DZIECKU

— bez wstydu, uczciwie

Klucz: Bycie rodzicem z ADHD *jest trudniejsze* — nie dlatego, że jesteś złym rodzicem, lecz dlatego, że rodzicielstwo **wymaga funkcji wykonawczych**, które są Twoim deficytem. To jak *bieg z ciężarem* — nie brak chęci, lecz dodatkowy wysiłek. Chronis-Tuscano i wsp. (2008): rodzice z ADHD, którzy **leczą siebie** (lek + terapia) zanim podejmą trening rodzicielski, osiągają o $d = 0,6$ lepsze wyniki w pracy z dzieckiem. **Najpierw maska tlenowa dla Ciebie**, potem dla dziecka. To nie egoizm — to *jedyny sposób*, by mieć co dać.